2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Os efeitos psicológicos atribuídos as mulheres que estão com monitoramento de agressores e medida protetivas judiciais para violência doméstica

M. F. G. de M. S. Alves[a,*], P. C. de Oliveira[b], A. Durello[c], C. da S. Catanho[d], G. K. Forte[e], J. A. M. da Silva[f], A. de A. Conrado[a], L. F. Costa[a], A. C. G. Dourado[a], M. Bushastsky[a]

[a]*Universidade de Pernambuco – UPE, Recife (PE), Brasil*

[b]*UNIFG; Instituto Social Plus, Recife (PE), Brasil*

[c]*Anhanguera Educacional, São Paulo (SP), Brasil*

[d]*Faculdade Metropolitana da Grande Recife, Recife (PE), Brasil*

[e]*Universidade Paulista, São Paulo (SP), Brasil*

[f]*Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Recife (PE), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: flavia.spinellitelecom@bol.com.br. Tel.: +55-81-99841-0264.*

Palavras-chave: Violência doméstica; Medidas protetivas; Traumas

1. INTRODUÇÃO

A medida protetiva de urgência, prevista na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é um dos principais instrumentos de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ela pode ser solicitada de forma rápida, inclusive sem a necessidade de inquérito policial, e tem como objetivo imediato interromper o ciclo de violência, garantindo à vítima um espaço seguro para reorganizar sua vida [1].

Entre as medidas mais aplicadas está a proibição de aproximação e contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, conforme o art. 22, inciso III da Lei Maria da Penha, essa determinação judicial estabelece um limite físico e psicológico, impedindo que o agressor se aproxime a uma distância mínima definida pelo juiz, e quando o agressor descumpre essa ordem, comete crime específico previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência: Pena – detenção, de 3 meses a 2 anos [1].

Além disso, dependendo da conduta, outros dispositivos do Código Penal podem ser aplicados: Art. 147 – Ameaça: "Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave." Pena: detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Art. 147-B – Perseguição (stalking): "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade." Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos, e multa [2].

Os efeitos psicológicos atribuídos as mulheres que estão com monitoramento e medida de afastamento do agressor podem incluir: Crises de pânico com sintomas como falta de ar; Palpitações e tremores; Insônia e dificuldade de concentração; Hipervigilância, com atenção constante a sons, movimentos e pessoas ao redor; Sensação de impotência e insegurança, que pode levar ao isolamento social; Agravamento de transtornos pré-existentes, como depressão e TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático) [3, 4 e 5]; Saffioti, 1999).

Esse cenário reforça a importância da lei 15.280 de 5 de dezembro de 2025, em seu art 338-A do Código Penal, que tipifica o descumprimento da medida protetiva, garantir a efetividade das ordens judiciais de urgência seja tratada com rigor policial e judicial, garantindo a segurança da vítima. Mas a resposta não deve ser apenas punitiva: é fundamental que a vítima tenha acesso a atendimento psicológico

especializado, acompanhamento social e redes de apoio comunitárias [1].

O objetivo do estudo inclui a necessidade de ir além da proteção integral, afirma que envolve não apenas impedir fisicamente a aproximação, mas também restaurar o senso de segurança emocional da mulher. Isso significa que o sistema de justiça, os órgãos de segurança e os serviços de saúde mental precisam atuar de forma integrada e continua, para que a vítima não se sinta sozinha ou desamparada. A aproximação do agressor em descumprimento de medida protetiva é um ato que fere a lei e ameaça diretamente a saúde mental da vítima.

2. METODOLOGIA

A metodologia usada é qualitativa com base em revisão bibliográfica e analise legislativa, constituição federal de 1988, Lei maria da penha e suas atualizações, lei de execução penal, e a análise das medidas de monitoramento eletrônico de agressores associada às medidas protetivas judiciais, na percepção dos impactos psicológicos nas vítimas de violência contra mulher, baseada em avanços normativos de proteção efetiva, e trazendo o papel essencial da rede de proteção a mulher.

3. JUSTIFICATIVA

Os efeitos psicológicos atribuídos as mulheres que estão com monitoramento e medida de afastamento do agressor, para além da violência física, sexual e psicológica tem sido associada com diversos problemas psiquiátricos tais como depressão, ansiedade, fobias,

estresse pós-traumático, suicídio, tentativa de suicídio, abuso de álcool e drogas, insônia, exacerbação de sintomas psicóticos, problemas alimentares, depressão pós-parto, transtorno bipolar [6, 7 e 8].

Para muitas sobreviventes, mesmo após a denúncia e a aplicação de medidas protetivas, o medo persiste, especialmente quando a proteção depende da monitoração eletrônica dos agressores. Embora dispositivos como tornozeleiras eletrônicas sejam ferramentas importantes para fiscalizar o cumprimento das medidas, comprovada sua eficácia, depende de resposta rápida das autoridades diante de violações e a percepção de que o sistema pode falhar, seja por demora no atendimento, falhas técnicas ou falta de fiscalização, mantém as vítimas em estado de alerta permanente, prejudicando seu processo de recuperação emocional. Esse medo constante pode levar à hipervigilância, isolamento social e dificuldade de retomar a rotina, reforçando o ciclo de sofrimento [3,4 e 5]. Além disso, a sobrecarga emocional é agravada pela necessidade de acompanhar o andamento do processo judicial e pela incerteza sobre a real segurança oferecida. Para reduzir esses impactos, é fundamental integrar a proteção física com o cuidado psicológico, garantindo acompanhamento terapêutico especializado, canais de comunicação ágeis com as forças de segurança e protocolos claros de resposta imediata em caso de risco. A confiança no sistema de monitoração não se constrói apenas com tecnologia, mas com presença efetiva do Estado e acolhimento contínuo às vítimas.

4. OBJETIVOS

Observar como os sistemas de monitoramento e as medidas protetivas judiciais, podem influenciar nos transtornos psicológicos da mulher, vítima de violência, e a necessidade de não apenas impedir fisicamente a aproximação, mas também restaurar o senso de segurança emocional da mulher, ressaltar que o sistema de justiça, os órgãos de segurança e os serviços de saúde mental precisam atuar de forma integrada e continua para saúde física e mental da mulher vítima de violência.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A violência de gênero tem sido fortemente associada a prejuízos na saúde mental das mulheres, tais como a configuração de quadros de depressão, ansiedade, fobias, transtorno pós-traumático, suicídio, problemas alimentares, demonstrando que o ainda a violência de gênero contra as mulheres não tem sido tratada claramente como um fator de risco para a saúde mental, a grande importância em propor aos serviços de saúde intervenções mais eficazes para lidar com mulheres que foram ou estão sendo vítimas de violência. [9, 10].

Assim, falta a integralidade nas ações acerca do adoecimento mental em mulheres com histórico de violência [11]

Ao falar da violência contra a mulher, o aspecto psicológico é visto como algo a ser preservado, como por exemplo, na Lei 11340/2006 (Maria da Penha), o texto traz, diversas vezes, a expressão "preservação da integridade física e psicológica" e os dados mostram que a opressão e a violência de gênero levam ao sofrimento e a uma diversidade de problemas psicológicos [12]. Portanto, ao se refletir sobre as políticas públicas, deve-se se levar em consideração os desdobramentos gerados pela violência, a fim de que intervenções mais eficazes sejam planejadas [11].

Os sintomas psicológicos quase sempre são: depressão, síndrome de estresse pós-traumático, ansiedade, fobias, desânimo, irritabilidade, síndrome do pânico, sensação de perigo iminente, ideação suicida, tentativa de suicídio, homicídio, baixa autoestima, sentimento de culpa, inferioridade, insegurança, vergonha, isolamento social, dificuldade de tomada de decisão, dependência ao extremo, hábito de fumar, uso de álcool, falta de concentração [13]. De acordo com a referência [14] mulheres que sofrem violência doméstica estão cinco vezes mais predispostas a apresentarem problemas psicológicos em comparação às mulheres que não vivenciam essa situação. Muitas vezes, a violência psicológica causa sequelas ainda mais graves que efeitos físicos. Surgem também sintomas sociais, apresentando faltas no trabalho, ausência ao serviço de saúde, isolamento, mudanças frequentes de emprego ou de cidade[15,16,17].

Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, tem-se que as pesquisas efetivamente apontam ser o uso de substâncias um fator agravante da violência doméstica, pela ação desinibidora da censura, e o agressor assume condutas reprováveis [13].

A referência [17]descrevem que as mulheres vítimas de violência doméstica manifestam elevados níveis de ansiedade, o que desencadeia a falência da capacidade adaptativa. Em termos físicos: sensações fisiológicas de sudorese, palpitação, inquietação e outros sintomas do sistema nervoso autônomo; segundo o [18] DSM-V (2014), os critérios diagnósticos são: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele; fadiga; dificuldade em concentrar-se; irritabilidade; tensão muscular, tamborilar dos dedos dos pés ou das mãos e perturbação no sono.

De acordo com a Legislação o uso da tornozeleira pode ser decidido pelo Judiciário tanto durante a investigação e na instrução criminal, como quando já existe uma condenação ou mesmo pelo pedido feito pela vítima, o uso da monitoração eletrônica em substituição à prisão provisória, e na medida protetiva de urgência, nos casos de violência doméstica [19]. No caso especifico da violência contra mulher pode ocorrer, alguns casos onde o descumprimento pode ser ocasionado por falhas técnicas, queda de sinal ou outras causalidades, nestas situações, a própria central de monitoramento, a partir de procedimentos preestabelecidos, poderá solucionar diretamente o incidente com a pessoa monitorada, e o juiz será informado sobre os incidentes para tomada de providências judiciais eventualmente cabíveis, apenas no caso de impossibilidade de solução é que a medida será considerada como descumprimento [20]

Em 24 de abril de 2025, foi sancionada a Lei nº 15.125, que alterou a própria Lei Maria da Penha. Essa nova legislação incluiu expressamente a sujeição do agressor a monitoramento eletrônico durante a aplicação de medida protetiva de urgência, além de prever a disponibilização de dispositivo de segurança (botão do pânico) para as vítimas [21].

Essa mudança legislativa é um divisor de águas, pois consolida a tornozeleira eletrônica como um mecanismo formal e previsto na legislação específica de proteção à mulher, reforçando a importância da tecnologia no combate à violência doméstica e familiar [1,2].

Existem desafios importantes como Custos de Implementação e Manutenção; O custo para o Estado de manter os equipamentos e a infraestrutura de monitoramento é considerável, o que pode limitar a abrangência da medida em algumas regiões; Limitações Tecnológicas, a tornozeleira monitora a localização, mas não impede outros tipos de contato, como ligações, mensagens ou perseguições virtuais, que também

podem configurar descumprimento das medidas protetivas, a vulnerabilidade da Vítima persiste quando a eficácia da medida está ligada à rapidez da resposta das autoridades e ao funcionamento adequado dos dispositivos, então vítima, mesmo com a tornozeleira, ainda pode se sentir em risco, sendo imprescindível o apoio psicológico e social contínuo , além do mais , fatores como a disponibilidade dos equipamentos e a estrutura de monitoramento podem variar entre os estados e municípios, criando disparidades na proteção oferecida às mulheres [21].

6. CONCLUSÕES

Em síntese, o monitoramento eletrônico por tornozeleira é uma ferramenta de proteção valiosa, que se integra ao arcabouço da Lei Maria da Penha. Sua eficácia, no entanto, é otimizada quando acompanhada de uma rede de apoio completa, que inclui o pronto atendimento das autoridades, o suporte psicológico e social à vítima, e o aprimoramento constante dos sistemas de monitoramento. É um passo importante na luta por uma vida sem violência para as mulheres brasileiras, pois muitas vezes a mulher sofre quando o equipamento dispara o sinal, o emocional da mulher tem grande comprometimento e o sistema de proteção deve estar atento a esse acolhimento no momento do acionamento. A sobrecarga emocional é agravada pela necessidade de acompanhar o anda-

mento do processo judicial e pela incerteza sobre a real segurança oferecida. Para reduzir esses impactos, é fundamental integrar a proteção física com o cuidado psicológico, garantindo acompanhamento terapêutico especializado, canais de comunicação ágeis com as forças de segurança e protocolos claros de resposta imediata em caso de risco. A confiança no sistema de monitoração não se constrói apenas com tecnologia, mas com presença efetiva do Estado e acolhimento contínuo às vítimas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 20 jan. 2026.

[2] BRASIL. Lei nº 15.280, de 5 de dezembro de 2025. Altera dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Pessoa com Deficiência para agravar penas e ampliar proteção em crimes contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 8 dez. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023 2026/2025/lei/L15280.htm

[3] FONSECA, D. H.; RIBEIRO, C. G.; LEAL, N. S. B. Violência doméstica contra a mulher: realidades e representações sociais. Psicologia & Sociedade, v. 24, n. 2, p. 307-314, 2012. . Governo do Estado de Pernambuco. CEMEP – Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas. Recife: Governo do Estado de Pernambuco, 2025..

[4] OLIVEIRA, L. R. C. Existe violência sem agressão moral? Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, n. 67, p. 136-146, 2008.

[5] SAFFIOTI, H. Já se mete a colher em briga de marido e mulher. São Paulo em Perspectiva - Revista da Fundação seade, v. 13, n. 4, 82-91, 1999.

HENRICA, M. E., JANSEN, A. F. M., HEISE, L., WATTS, C. H., & GARCIA-MORENO, C. Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: na observational study. Thelancet.com, n. 37, p. 1165-1172, 2008.

ROSE D, TREVILLION K, WOODALL A, MORGAN C, FEDER G, HOWARD L. Barriers and facilitators of disclosures of domestic violence by mental health service users: qualitative study. Br J Psychiatry. Mar, n. 198, v. 3, p. 189-94. 2011.

TREVILLION, K., HUGHES, B., FEDER, G., BORSCHMANN, R., ORAM, S., & HOWARD, L. M. Disclosure of domestic violence in mental health settings: A qualitative meta-synthesis. International Review of Psychiatry, n. 26, v. 4, 430–444. 2014.

[6] BARBOSA, L. B.; DIMENSTEIN, M.; LEITE, J. F. Mulheres, violência e atenção em saúde mental: questões para (re)pensar o acolhimento no cotidiano dos serviços. Av. Psicol. Latino., Bogotá, v. 2, pág. 309-320, agosto de 2014. Disponível em <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-47242014000200009&lng=en&nrm=iso>. acesso em 29 de março de 2026.

[7] PEDROSA, M., & ZANELLO, V. Visibilidade da violência contra as mulheres na saúde mental. Psicologia: Teoria e Pesquisa, n. 32, v. 5, p. 1-8. 2017.

[8] MEDEIROS, M. P. de e ZANELLO, V.. Relação entre a violência e a saúde mental das mulheres no Brasil: análise das políticas públicas. Estud. pesqui. psicol. [online]. 2018, vol.18, n.1, pp.384-403. ISSN 1808-4281.

[9] CHESLER, P. Women and Madness. New York: Palgrave MacMillan, 2005.

DAY, V.P.; TELLES, L.E.B.; ZORATTO, P.H.; AZAMBUJA, M.R.F.; MACHADO, D.A.; SILVEIRA, M.B.; DEBIAGGI, M.; REIS, M.G.; CARDOSO, R.G.; BLANK, P. Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, v. 25, n. 1, p. 09-21, 2003.

[10] GROSSI, M.P.; MIGUEL, M.M. Mulheres na política, mulheres no poder. 2001.

[11] MANDELBAUM, B.; SCHRAIBER,L.B.; D'OLIVEIRA, A.F.P.L. Violência e vida familiar: abordagens psicanalíticas e de gênero. Saude soc. n.25, v. 2, Apr-Jun, 2016.

[12] SILVA, L.L., COELHO, E.B.S.; CAPONI, S.N.C. Violência silenciosa: violência psicológica como condições da violência física doméstica. Interface – Comunicação, Saúde, Educação. Botucatu, v. 11, n. 21, p. 93-103, 2007.

[13] BITTAR, D.; KOHLSDORF, M. Ansiedade e depressão em mulheres vítimas de violência doméstica. Psicologia Argumento. Curitiba, v. 31, n. 74, p. 447-456, jul./set. 2013.

[14] Associação Psiquiátrica Americana. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5 (5ª ed.). Artmed. 2014.

[15] BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Monitoração eletrônica de pessoas: informativo para órgãos de segurança pública. Brasília, DF: DEPEN; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 2020

[16] BRASIL. Lei nº 15.125, de 24 de abril de 2025. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para prever a monitoração eletrônica como instrumento de efetividade das medidas protetivas de urgência. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 abr. 2025. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2025/lei-15125-24-abril-2025-797344- norma-pl.html. Acesso em: 17 dez 2025.

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. [s.d.]